Клинические рекомендации

Инородное тело в пищеварительном тракте

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**T18** — Инородное тело в пищеварительном тракте
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов" ; Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/710_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 4

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 5

3. Диагностика 5

3.1 Жалобы и анамнез 5

3.2 Осмотр 6

3.3 Анализы крови 6

3.4 Рентгенография 6

3.5 Рентгеноскопия с контрастом 6

3.6 КТ 7

3.7 Эндоскопия 7

3.8 Дифференциальная диагностика 7

4. Лечение 7

4.1 Сроки эндоскопии 7

4.2 Консервативное ведение 8

4.3 Эндоскопическое лечение 8

4.4 После удаления 9

4.5 Препараты 10

4.6 Хирургическое лечение 10

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11

5.1 Организация помощи и госпитализация 11

5.2 Реабилитация и профилактика 12

6. Источник и актуальность 12

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13

1. Основные положения

- Инородное тело — любой объект, проглоченный, введённый в просвет пищеварительного тракта или образовавшийся в нём, который не может служить пищей. Большинство (80–90%) выходит самостоятельно; эндоскопия нужна в 10–20%, операция — менее чем в 1%.
- При поступлении — осмотр оториноларинголога (исключить инородное тело полости рта и глотки) и хирурга (признаки перфорации и других осложнений).
- Диагноз — инородное тело, найденное при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании либо при операции.
- Батарейка, остроконечный предмет или полная обструкция в пищеводе — эндоскопия **экстренно: лучше в течение 2 часов, не позднее 6**; прочие инородные тела пищевода, в том числе магниты, — **срочно, в течение 24 часов**.
- Батарейки и магниты консервативно не ведут; контейнеры с наркотиками эндоскопически не удаляют.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Инородное тело пищеварительного тракта — объект органического, неорганического или искусственного происхождения, случайно или намеренно проглоченный, введённый в просвет пищеварительного тракта или образовавшийся в организме, который по составу и (или) расположению не может служить пищей.

Условно инородные тела — пища, желчные камни, паразиты, становящиеся инородным телом при определённых обстоятельствах: вклинение пищевого комка в зону сужения пищевода, миграция желчного камня в просвет кишки, конгломерат паразитов.

Инородные тела по воздействию на стенку

Вид	Определение
Инертные	без выраженного патологического воздействия на стенку: монеты, мелкие игрушки, клипсы, стеклянные и металлические шарики
Механически активные	механическое повреждение стенки: иголки, булавки, саморезы, проволока
Физически активные	выраженное физическое, компрессионное воздействие: магниты
Химически активные	химические и термические ожоги вплоть до перфорации: дисковые батарейки таблеточного типа
С комбинированным воздействием	механическое (обтурация, компрессия) и химическое воздействие: безоары, силикагелевые шарики

Признак Турнера — ощущение инородного тела в гортаноглотке или пищеводе даже после его прохождения в желудок.

2.2 Этиология

У детей чаще, чем у взрослых; пик — от 6 месяцев до 6 лет. Самые частые у детей — монеты: через пищевод самостоятельно проходят у 30–60%. Застрявшая в пищеводе дисковая батарейка — угрожающее жизни состояние (трахеопищеводный и трахеоаортальный свищ, медиастинит, абсцесс шеи). Взрослые глотают инородные тела случайно или намеренно (психические заболевания, заключённые), «курьеры» — контейнеры с наркотиками; бывают ятрогенные инородные тела (видеокапсулы, стенты, зубные протезы).

2.3 Классификация

1. **по происхождению** — истинные (проглоченные умышленно, случайно, незаметно; введённые через задний проход; оставленные при вмешательствах; попавшие при травме) и условно инородные тела (вклиненный пищевой комок; желчные камни, безоары, каловые камни; живые инородные тела)
2. **по локализации** — пищевод — 68,4%, желудок — 18,9%, тонкая кишка — 7,1%, толстая — 3%, прямая — 2,6%

1. **по количеству** — единичные, множественные
2. **по динамике** — мигрирующие, свободнолежащие, фиксированные
3. **по величине** — мелкие — **до 2–2,5 см в диаметре или до 5 см в длину**; средние — 2,5–5 см или до 10 см; крупные — более 5 см или более 10 см
4. **по воздействию** — инертные; потенциально агрессивные (контейнеры с наркотиками, хрупкие предметы); агрессивные — химически (батарейки), физически (магниты, ртуть), механически активные (остроконечные), комбинированные (безоары, силикагель)

Рентгеноконтрастность инородных тел

Контрастность	Инородные тела
рентгеноконтрастные, хорошо видны на снимке	истинные рентгенопозитивные инородные тела непищевого происхождения, мясные кости
малоконтрастные и рентгенонегативные, как правило, не видны	пищевой комок, рыбьи и куриные кости, дерево, пластик, стекло, тонкие металлические предметы

Классификация Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии

Тип	Примеры
тупые	монета, пуговица, игрушка; батарейки, магниты
остроконечные	игла, зубочистка, кость, булавка, осколки стекла; фрагмент зубного протеза, лезвие
длинные	мягкие (струна, верёвка), твёрдые (зубная щётка, столовый прибор, отвёртка, ручка)
пищевые комки	с костями или без
другие	контейнеры с запрещёнными веществами

2.4 Клиническая картина

У детей зона глоточно-пищеводного перехода уже и длиннее, поэтому инородное тело чаще застревает в шейном отделе пищевода. Непищевые инородные тела составляют 75–90%, чаще возникает респираторный синдром.

Проявления у детей

1. кашель, одышка, свистящее дыхание, ложный круп;
2. гиперсаливация, слюнотечение, поперхивание, рвота;
3. дисфагия, одинофагия, отказ от еды, ощущение комка в горле.

У части детей симптомов нет до развития осложнений.

Инородное тело пищевода у взрослых (выраженная картина у 50–68%)

1. боль по ходу пищевода, в яремной ямке, затылке, спине, эпигастрии;
2. слюнотечение, невозможность проглотить твёрдую и жидкую пищу, дисфагия, срыгивание;
3. одышка; вынужденное положение при инородном теле в виде «якоря».

Вторичные проявления

1. лихорадка, обезвоживание, запах изо рта;
2. осиплость голоса;
3. инфильтрация мягких тканей шеи, подкожная эмфизема, пневмоторакс.

10% инородных тел пищевода бессимптомны; «мнимые» инородные тела — 10–15%.

Инородные тела желудка и ДПК проявляются слабо — только крупные, длинные и острые; пролежень и перфорация дают перитонеальные симптомы или забрюшинный инфильтрат. Крупные инородные тела прямой кишки — тенезмы, боль в промежности, кровь в стуле. Отсутствие симптомов не повод отказаться от обследования.

---

3. Диагностика

Диагноз — обнаружение инородного тела при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании либо при операции. На догоспитальном этапе и при поступлении основание — анамнез и осмотр.

3.1 Жалобы и анамнез

Тщательная оценка жалоб и детальный анамнез.

Выяснить

1. что проглочено (на снимке монета похожа на дисковую батарейку);
2. сколько прошло времени, когда последний раз ел и пил;
3. пытался ли пациент сам извлечь или «протолкнуть» инородное тело (сухой хлеб);
4. были ли попытки эндоскопического удаления;
5. были ли такие эпизоды; эозинофильный эзофагит, ГЭРБ, рубцовая стриктура, ахалазия;
6. у детей — стенозы, ожоги, операции на пищеводе: дисфагия, слюнотечение, отказ от еды, апноэ при кормлении — показание к эзофагоскопии.

Гиперсаливация и невозможность глотать жидкость — признаки полной непроходимости пищевода; удушье, стридор, одышка — аспирация или сдавление трахеи.

3.2 Осмотр

При поступлении

1. оториноларинголог — подтвердить или исключить инородное тело в полости рта и глотке;
2. хирург — признаки перфорации пищевода (подкожная эмфизема, отёк, инфильтрат шеи), осложнения со стороны желудка и кишечника;
3. аускультация лёгких — хрипы, аспирация;
4. подозрение на инородное тело прямой кишки — пальцевое исследование.

Лихорадка и тахикардия — настораживают в отношении осложнения; при длительно стоящем инородном теле пищевода и отсутствии торакального отделения — перевод в профильный стационар или вызов специалиста.

3.3 Анализы крови

При поступлении

1. общий анализ крови;
2. биохимия: глюкоза, мочевина, креатинин, амилаза, билирубин, АЛТ, АСТ.

По показаниям

1. калий, натрий, тромбоциты;
2. АЧТВ, МНО, фибринолитическая активность;
3. группа крови и резус-фактор.

3.4 Рентгенография

Подозрение на рентгеноконтрастное инородное тело или характер инородного тела неизвестен — неотложная рентгенография мягких тканей шеи, органов грудной клетки и брюшной полости.

Сначала прямая проекция; ложноотрицательных результатов **до 47%**, поэтому при отрицательном результате — боковая. Шейный отдел пищевода — снимок шеи в боковой и прямой проекции с приподнятой головой.

Дети с подозрением на проглатывание инородного тела, даже без симптомов, — неотложная рентгенография шеи, грудной клетки и брюшной полости, таза в 2 проекциях по показаниям.

Застрявший пищевой комок без костей и без признаков осложнений — обзорная рентгенография, как правило, **не рекомендуется**: ложноотрицательных результатов до 87%.

3.5 Рентгеноскопия с контрастом

Подозрение на обтурацию или перфорацию пищевода, рентгенонегативное инородное тело, сомнения в локализации — рентгеноскопия глотки и пищевода с водорастворимым йодсодержащим контрастом; не должна задерживать эндоскопию.

Контраст — малыми порциями. При нарушении глотания (инородное тело на уровне глоточно-пищеводного перехода, неврологические заболевания) йодсодержащий контраст **не применяют**: аспирация и отёк лёгких.

Бария сульфат **не рекомендуется**: риск аспирации, затрудняет последующую эндоскопию.

3.6 КТ

Клиника перфорации пищевода, флегмоны шеи, медиастинита и других осложнений — КТ органов грудной и брюшной полости.

Рыбьи кости — частые инородные тела у взрослых, застревают в верхней части пищевода; чувствительность рентгенографии **32%**, КТ — **90–100%**. У детей КТ — при рентгенонегативных инородных телах. Свободный газ под диафрагмой при перфорации инородным телом — ненадёжный признак.

3.7 Эндоскопия

До эндоскопии — анализ клинической картины и данных лучевых исследований: выбор обезболивания, эндоскопа, инструментов.

Всем с подозрением на инородное тело верхних отделов — ЭГДС, в том числе при отрицательном рентгенологическом результате; это и первый этап лечебного вмешательства. У детей инородное тело пищевода удаляют **менее чем через 24 часа**.

Подозрение на инородное тело прямой или сигмовидной кишки — ректороманоскопия.

3.8 Дифференциальная диагностика

Похожая картина бывает при

1. кандидозном, рефлюкс- и эозинофильном эзофагите;
2. ахалазии кардии;
3. после инсульта, в дебюте рассеянного склероза, БАС, миастении;
4. опухоли пищевода;
5. истерии и других заболеваниях нервной системы.

Интенсивная боль за грудиной — исключить острый коронарный синдром; инородное тело желудка и кишки — заболевания с картиной острого живота.

---

4. Лечение

4.1 Сроки эндоскопии

Сроки эндоскопического вмешательства: экстренно — лучше в течение 2 часов, не позднее 6; срочно — в течение 24 часов; отсроченно — в течение 72 часов

Инородное тело	Пищевод	Желудок, тонкая кишка
батарейка	экстренно	срочно
магнит	срочно	срочно
остроконечное	экстренно	срочно
тупое, менее 2–2,5 см	срочно	отсроченно
тупое, 2–2,5–5 см	срочно	отсроченно
большое, более 5–6 см	срочно	срочно
пищевой комок	экстренно (срочно — без симптомов и полной обструкции)	—

4.2 Консервативное ведение

Наблюдение без извлечения — если инородное тело не в пищеводе, симптомов нет, оно тупое, инертное и небольшое (**до 2–2,5 см в диаметре или 5 см в длину**).

После пищевода большинство инородных тел проходит ЖКТ за **4–6 дней**, редко — до 4 недель; через привратник не проходят предметы более 2–2,5 см, через изгиб ДПК — длиннее 5–6 см. Без симптомов при инородном теле желудка меньше этих размеров возможно амбулаторное наблюдение: пациента предупреждают о симптомах перфорации и непроходимости.

Наблюдение за небольшим тупым рентгеноконтрастным инородным телом — периодический рентгенологический контроль, без симптомов — еженедельно; не вышло из желудка **за 3–4 недели** — эндоскопическое удаление.

Контейнеры с наркотиками без симптомов — пристальное наблюдение в стационаре, лаваж кишечника, рентгенологический контроль; эндоскопически не удаляют.

Безоар желудка — сначала 5–10% раствор пищевой соды или напитки с ортофосфорной кислотой: размягчают растительные безоары; продолжать между сеансами эндоскопии.

Консервативное ведение противопоказано

1. магниты и батарейки;
2. остроконечные инородные тела;
3. безоары, силикагелевые шарики;
4. любые длительно стоящие инородные тела пищевода.

Магнит удаляют, даже если на снимке он один.

4.3 Эндоскопическое лечение

Перед удалением — анализ анамнеза, клиники, лучевых данных и эндоскопической картины: выбор обезболивания, эндоскопа, инструментов.

Экстренно (лучше в течение 2 часов, не позднее 6) — полная обструкция пищевода, остроконечные предметы и батарейки в пищеводе; **срочно (в течение 24 часов)** — остальные инородные тела пищевода, в том числе магниты.

Остроконечные предметы перфорируют до 35% случаев. Дисковая батарейка быстро повреждает пищевод: электрический ожог, утечка щелочи, пролежень. Цилиндрическая батарейка у ребёнка в пищеводе — экстренно. Риск тяжёлых осложнений при инородном теле в пищеводе **более 24 часов** выше в 14,1 раза.

Желудок и проксимальная ДПК: у детей с симптомами остроконечные, крупные инородные тела, магниты и батарейки — **экстренно (в первые 2 часа)**; у взрослых и у детей без симптомов (магниты) — **срочно (24 часа)**.

Дисковые батарейки у детей — независимо от симптомов, размера и количества — удаляют **лучше в течение 12 часов, не позднее 24**: после 12 часов риск осложнений выше в 4,5 раза. Инородные тела более 2–2,5 см — в течение 24–48 часов; тупое небольшое, не покинувшее желудок за 3–4 недели (лучше не более 1 недели), — эндоскопически.

Крупные инородные тела прямой кишки — экстренное удаление, особенно у детей: под наркозом после девульсии ануса, зажимами Кохера.

Удаление — под общим обезболиванием; у детей — только под наркозом с интубацией трахеи (или внутривенно с сохранением спонтанного дыхания, глубокая седация). У взрослых нетравмоопасные инородные тела — под внутривенной анестезией или седацией, при невозможности — под местной анестезией.

Метод выбора — гибкая видеоэндоскопия: успех более 95%, осложнения 0–5%. Ригидная эзофагоскопия — только при инородном теле в верхней трети пищевода, которое не удаётся извлечь гибким эндоскопом, при перфорации в операционной перед дренированием средостения или если гибкой эндоскопии нет.

Длительно стоящее инородное тело или прежние безуспешные попытки — в операционной с инсуффляцией углекислого газа. Раскрытую булавку проводят в желудок, разворачивают и извлекают; острый конец направляют дистально; длинный предмет захватывают за кончик.

Остроконечные инородные тела — защитные устройства: дистальный колпачок, конус, тубус (дистальнее пищевода — 45–60 см).

Специальные инструменты по типу инородного тела: щипцы «зуб крысы», «зуб аллигатора», полипэктомические петли, корзины, сетчатые ловушки; биопсийные щипцы не рекомендуются.

Инструменты для извлечения у взрослых

Тип	Инструменты
тупые	щипцы-ретракторы, захваты, полипэктомические петли, корзинки, сетчатые ловушки
остроконечные	щипцы-ретракторы, петли, корзинки, сетчатые ловушки; прозрачный колпачок, латексный конус
длинные	полипэктомические петли, корзинки
пищевые комки	щипцы-ретракторы, захваты, петли, корзинки, сетчатые ловушки

Пищевой комок — осторожно низвести в желудок; не удаётся — извлечь целиком или по частям. При значительном сопротивлении проталкивание прекращают.

Эндоскопическое удаление контейнера с наркотиками **не рекомендуется**: разрыв ведёт к тяжёлой интоксикации и смерти.

Перфорация с флегмоной, медиастинитом, перитонитом — изолированное эндоскопическое удаление противопоказано; возможно в операционной во время хирургического вмешательства.

Прекратить попытки при неостанавливаемом кровотечении и если дальнейшие попытки под наркозом увеличивают риск повреждения стенки (рыболовный крючок, проволока «егоза»).

После извлечения — обязательно осмотреть место фиксации и путь извлечения, оценить повреждение стенки.

«Свежая» перфорация пищевода (**до 6 часов**) — эндоскопическое клипирование, с инсуффляцией углекислого газа.

После вклинения пищевого комка или задержки тупого инородного тела — обследовать место задержки: стриктура, эозинофильный эзофагит, ахалазия, опухоль.

Патология пищевода — более чем у 75% пациентов с вклинением пищевого комка: стриктуры (более 50%), эозинофильный эзофагит (около 40%). При подозрении на эозинофильный эзофагит — биопсия из трёх третей пищевода. Стриктуры и кольца Шацкого можно расширить сразу; при повреждении слизистой — ингибиторы протонного насоса и дилатация через 2–4 недели.

4.4 После удаления

Значительное повреждение слизистой или глубокое ранение острым предметом — рентгеноскопия с водорастворимым контрастом: исключить перфорацию; поздняя перфорация от пролежня — **на 2–5-е сутки**.

Травма стенки пищевода с отёком, а инородное тело не найдено — после противовоспалительной терапии повторить рентгеноскопию с контрастом и эзофагоскопию, особенно если проглочена рыбья кость.

Выраженный отёк слизистой пищевода — щадящая диета **3–4 дня** (жидкая, прохладная пища), ибупрофен или парацетамол; возможны масляные растворы бета-каротина, облепиховое масло, гиалуроновая кислота, ИПП.

Воспаление, изъязвления, трещины прямой кишки — НПВП в суппозиториях.

Значительное повреждение слизистой или ушитая перфорация — короткий курс антибиотиков (цефалоспорины, пенициллины); даже без перфорации — наблюдение в стационаре **2–3 дня**.

Операция по поводу перфорации, флегмоны, медиастинита, перитонита — антибиотики широкого спектра внутривенно как можно раньше, предпочтительно резервные (карбапенемы).

4.5 Препараты

Препараты до и после вмешательства

Препарат	Применение
ибупрофен	дети до 6 лет — по возрасту и массе, не более 30 мг/кг в сутки, интервал 6–8 ч: 3–6 мес — по 50 мг 3 раза (до 150 мг); 6–12 мес — по 50 мг 3–4 раза (до 200 мг); 1–3 года — по 100 мг 3 раза (до 300 мг); 4–6 лет — по 150 мг 3 раза (до 450 мг); взрослые и дети старше 6 лет — 200–400 мг 3–4 раза; максимум в сутки: 6–12 лет — 800 мг, 12–17 лет — 1000 мг, взрослые — 1200 мг
кетопрофен	старше 15 лет: в/м 100 мг 1–2 раза в сутки; в/в 100–200 мг в 100–150 мл 0,9% натрия хлорида, только в стационаре
парацетамол	более 50 кг — 1 г до 4 раз в сутки; 10–50 кг — 15 мг/кг до 4 раз; до 10 кг — 7,5 мг/кг до 4 раз; противопоказан новорождённым
цефазолин, цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон	профилактика хирургической инфекции, дозы по инструкции; цефотаксим в/м противопоказан до 2,5 лет, цефтриаксон — недоношенным до 41 недели
оксациллин; амоксициллин + клавулановая кислота	по инструкции; амоксициллин + клавулановая кислота противопоказан до 2 лет

4.6 Хирургическое лечение

Показания к операции

1. инородное тело не удалось извлечь эндоскопически;
2. длительно стоящее в тонкой кишке, не извлекаемое при энтероскопии;
3. перфорация с флегмоной, медиастинитом, перитонитом;
4. тонкокишечная непроходимость;
5. кровотечение, не останавливаемое эндоскопически.

Опасное инородное тело за связкой Трейца, не продвигающееся **3 дня**, — рассмотреть операцию; видеокапсула — задержка в тонкой кишке **более 2 недель**.

Контейнеры с наркотиками — операция при подозрении на нарушение упаковки, отсутствии продвижения, кишечной непроходимости.

Объём операции — по локализации и осложнениям. Перфорация пищевода **более 6 часов**, как правило, уже с медиастинитом.

Операция при перфорации пищевода

1. торакотомия, медиастинотомия;
2. удаление инородного тела, ушивание пищевода;
3. дренирование средостения и плевральной полости.

Перфорация прямой кишки на всю толщину — защитная колостома.

Диаметр пищевода по возрасту

Возраст	Диаметр пищевода
новорождённый	5–6 мм
6 месяцев	8–9 мм
1 год	12 мм
3–6 лет	13–15 мм
15 лет	18–19 мм
взрослый	20–22 мм

Эндоскопы для верхних отделов у детей

Масса ребёнка	Эндоскоп, мм	Канал, мм
новорождённые и младенцы до 10 кг	4,9–5,9	2,0–2,2
от 10 кг	7,8–9,2	2,2–2,8
более 25 кг — стандартные взрослые эндоскопы	9,2–9,9 и более	2,8–3,7

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Организация помощи и госпитализация

Подозрение на инородное тело пищевода в поликлинике — обзорная рентгенограмма шейного отдела пищевода и направление в стационар с оториноларингологом и эндоскопической службой.

Нельзя

1. вызывать рвоту и «проталкивать» инородное тело жёсткой пищей;
2. промывать пищевод и желудок на дому.

Все пациенты — в многопрофильный стационар с круглосуточной эндоскопией; аспирация, перитонит, кишечная непроходимость — в ОРИТ.

Тупое инертное инородное тело до 2–2,5 см без симптомов — амбулаторно. После успешного удаления без осложнений и без серьёзного повреждения стенки — выписка сразу.

Госпитализация для наблюдения

1. технически сложное извлечение;
2. несколько предметов, остроконечные, батарейки, магниты, предметы более 5–6 см;
3. обширное повреждение слизистой;
4. травма пищевода 3–5 степени;
5. травма стенки без найденного инородного тела; патология пищевода, имитировавшая инородное тело.

Не извлечённые острые предметы — ежедневные снимки; батарейки за ДПК — каждые 3–4 дня.

Травмы пищевода (видоизменённая классификация Bassett, 1980)

Степень	Эндоскопическая картина
1	отёк и гиперемия слизистой, обилие слизи (катаральный эзофагит)
2	одиночные царапины, повреждены только верхние слои слизистой
3	значительный отёк, мелкие подслизистые кровоизлияния, скудное кровотечение — повреждена вся толща слизистой
4	слизистая разрушена на значительном протяжении, большие подслизистые гематомы, фибрин, контактная кровоточивость
5	глубокие слепые ранения со слизистой на подслизистый слой, отслойка слизистой 1–2 см, пролежень — повреждён внутренний мышечный слой
6	перфорация, глубокое непроникающее ранение с обильным кровотечением

5.2 Реабилитация и профилактика

После осложнений и операций — реабилитация по осложнению и виду операции; после самостоятельного отхождения или неосложнённого эндоскопического удаления специальная реабилитация, как правило, не нужна.

Разъяснять родителям недопустимость оставлять детей без присмотра.

Трихобезоар — наблюдение психиатра и (или) невролога; ЭГДС **каждые 6–12 месяцев в течение 2–3 лет**.

Лечение заболевания пищевода, вызвавшего вклинение пищевого комка: стриктура, эозинофильный эзофагит, опухоль.

Исход во многом определяет состояние пищевода: опухоли, ахалазия, дивертикулы, ожоговые стриктуры, эзофагит, врождённая патология — тактика индивидуально.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Инородное тело в пищеварительном тракте»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 17.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	`710_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация детских хирургов; Российское общество хирургов; Российское общество рентгенологов и радиологов; Эндоскопическое общество

	«РЭндО»
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.